

INFORME BROTE INTRAHOSPITALARIO POR ROTAVIRUS Y ADENOVIRUS UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
E.U. Paulina Antonucci Sotomayor Encargada Programa Control de Infecciones E.U. Lilian Barja Muñoz Enfermera Programa Control de Infecciones T.M. Camilo Alcámán Rodríguez Encargado de Microbiología	Dra. Yadira Páez Médica Infectología Control de Infecciones T.M. Clara Galvez Leal Jefa de Unidad de Laboratorio E.U. Macarena Escobar Armijo DEPTO. DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Junio a julio 2024	Dra. Patricia Mellado Reyes S.S.M.C. Directora (S) Hospital El Carmen de Maipú Dr. Luis Valentin Ferrada

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	3
II. DESARROLLO	4
<i>Detección y diagnóstico de brote</i>	4
Intervenciones realizadas	7
<i>Fechas de Hitos de Brote Epidémico</i>	10
<i>Desenlace</i>	11
Envío de muestras a ISP	11
III. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES	12

I. INTRODUCCIÓN

La vigilancia epidemiológica (VE) ante sospecha de brotes es una de las funciones esenciales del Programa de Control de infecciones, la cual consiste en la recolección de datos, análisis, interpretación y difusión de información e indicaciones ante el problema de salud determinado, siendo una herramienta fundamental para la planificación, ejecución, toma de decisiones y evaluación de las prácticas de asociadas a la atención de salud, permitiendo contener el brote epidémico y prevenir nuevos casos asociados, disminuyendo el riesgo de morbilidad en los usuarios de la institución.

La infección por el *Rotavirus* es la causa más común de diarrea en niños menores de cinco años en todo el mundo. Su periodo de incubación va desde las 24 a 72 horas.

Los *Adenovirus* son un grupo de virus que típicamente causan enfermedades respiratorias como resfriados, conjuntivitis, bronquiolitis o neumonía. En los niños, los *Adenovirus* generalmente causan infecciones en los tractos respiratorio e intestinal. Los *Adenovirus* entéricos tienen un periodo de incubación entre 3 y 10 días.

Estos virus suelen diseminarse a través de manos contaminadas, o vía fecal oral. Es por esto por lo que el personal de servicios de salud, familiares y personal que realiza los cuidados de los niños en guarderías deben mantener PAE por Contacto, segregación de pañales contaminados, y un estricto manejo de precauciones estándar como el lavado de manos en los 5 momentos indicados por la OMS.

El servicio de Neonatología del HEC, es una unidad “abierta”, que se encuentra con separación de cupos que permite realizar el distanciamiento de los pacientes a más de un metro, pero no cuenta barreras físicas que delimitan este espacio, por razones clínicas y de vigilancia de los pacientes. Cuenta con una sala llamada de transición, en donde en algunas ocasiones, se han podido generar aislamientos en cohorte en este espacio. Los médicos tratantes, atienden tanto pacientes que se encuentran en los cupos UCI como Intermedios, y el resto del equipo clínico divide las atenciones por área, pero siempre existen brechas en cuanto a los turnos de colaciones, momento en el cual, personal clínico atiende a otros pacientes también, con tal de cubrir.

Tras la detección de un aumento de casos intrahospitalarios, PCI realiza análisis correspondiente para posteriormente determinar y declarar brote epidémico. Éste debe ser reportado de inmediato a la Autoridad sanitaria correspondiente por medios establecidos de acuerdo con el Decreto N° 7 Reglamento sobre Notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia, y a las autoridades locales de la propia institución.

Este informe da a conocer el **agente, fecha de inicio y término de brote, número de casos y expuestos, servicio afectado y curva epidémica, como así, su respectivo análisis de sus causas, intervenciones realizadas y evaluación de su impacto.**

II. DESARROLLO

Detección y diagnóstico de brote

Durante la semana epidemiológica n°24 se presenta aumento de casos de *Rotavirus* (RTV) y *Rotavirus + Adenovirus* (RTV+ADV) (4 casos en total, uno de ellos desestimado como IAAS debido a que muestra fue procesada en dicha semana, pero paciente ya poseía antecedentes de infección gastrointestinal previos, considerándose como parte del mismo cuadro, y que además no presentó nexos epidemiológicos con resto de pacientes por ubicación y diferencia en agentes etiológicos; paciente es positivo para RTV y ADV; y, los otros pacientes que salieron positivos en semana epidemiológica n°25 eran sólo RTV). Ante ello, PCI realiza visita a la unidad y evalúa casos en conjunto con jefe médico subrogante y jefa de matronería de la unidad, dictaminando medidas de prevención de brote a Neonatología (**anexo 1**), sin embargo, durante el transcurso del día 18-06-2024 se suman 3 casos positivos más, ante lo cual, jefatura médica subrogante de Neonatología decide realizar testeo de deposiciones en búsqueda de RTV+ADV al resto de pacientes hospitalizados, resultando un total de 18 muestras positivas (contando los casos anteriores mencionados). Dado lo anterior es que PCI se reúne con jefatura de Neonatología para establecer medidas a tomar, entregando la información a Subdirección de Gestión Asistencial para determinar en conjunto, bloqueo de cupos de Neonatología ante la presencia del elevado número de casos contagiados y riesgo asociado a ello.

Se notifica brote epidémico por *Rotavirus y Adenovirus* en el servicio de Neonatología el día 19-06-2024 en semana epidemiológica n°25.

Si bien, el total de pacientes con resultado de muestras positivas hasta el 19 de junio es de 18, se considerará de ahora en adelante como caso perteneciente al brote, sólo aquellos pacientes que se encuentran sintomáticos y que cumplen con la definición de Infección Gastrointestinal en neonatos y lactantes descrita en el documento ministerial "*Definición y Criterios de notificación de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) para la vigilancia epidemiológica, 2023*", entendiendo que las medidas descritas en los próximos puntos a tratar aplican para todos los pacientes positivos, independiente de su sintomatología.

De los casos mencionados anteriormente se concluye:

- **Caso índice:**

Paciente de sexo masculino, de 1 mes de edad, hospitalizado en cupo 238i, quien se encontraba en su día 49 de hospitalización, y que inicia síntomas gastrointestinales el día **18 de junio 2024, resultando positivo para RTV+ADV** mediante inmunocromatográfica.

- **Caso primario:**

Paciente de sexo femenino, de 2 meses de edad, hospitalizado cupo 238j, quien se encontraba en su día 9 de hospitalización al momento de iniciar síntomas gastrointestinales el día **10 de junio 2024, resultando positiva el mismo día para RTV** mediante.

- **Casos secundarios:**

Todo paciente posterior al caso primario que presentan nexo epidemiológico y sintomatología gastrointestinal, más resultado positivo para *Rotavirus* y/o *Adenovirus*:

- ❖ Paciente de sexo femenino, de 9 días de edad, hospitalizado en cupo 468B, quien en su día 10 de hospitalización inicia síntomas gastrointestinales (11/06), con resultado positivo para RTV+ADV el mismo día.
- ❖ Paciente de sexo masculino de 29 días de edad, quien en su día 57 de hospitalización inicia síntomas gastrointestinales (12/06) en sala 238ñ, resultando positivo para RTV el mismo día.
- ❖ Paciente de sexo masculino de 4 meses de edad, quien en su día 140 de hospitalización inicia síntomas gastrointestinales (18/06) en sala 238g, resultando positivo para RTV el mismo día.

La totalidad de casos positivos sintomáticos correspondientes al brote es de **5 pacientes**, de los cuales **2 son positivos para RTV+ADV** y **3 son positivos para RTV**.

Posterior a la detección, análisis y declaración del brote, se **notifica a jefatura de la Unidad, Subdirección de Gestión Asistencial (SDGA), Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) y registra en plataforma SICARS el día el 21 junio 2024**. La **validación y autorización** del brote epidemiológico es realizada el mismo día, con las siguientes conclusiones:

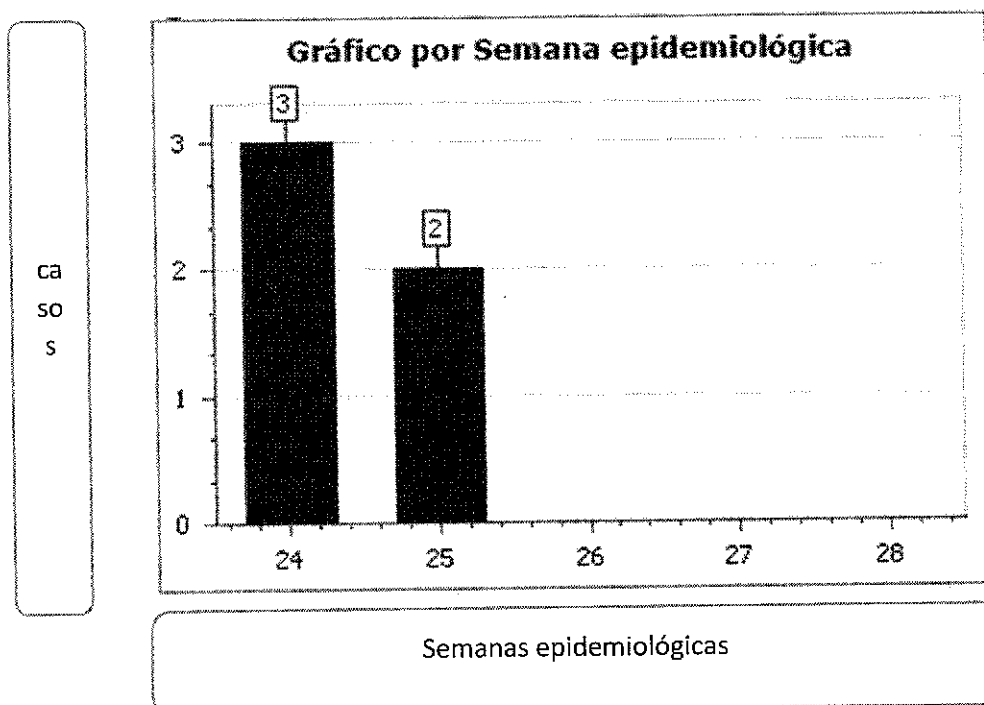
- **Hipótesis:**

- Quiebre de medidas de prevención de IAAS, falla en el cumplimiento y supervisión de manejo de precaución estándar y adicional por parte de personal clínico, familiares y personal de aseo.

- Quiebre de medidas de prevención de IAAS, posible mal procesamiento de muestra (descartado tras análisis en conjunto a microbiología).
- **Definición de caso:** Pacientes con más de 2 días calendario de hospitalización en Unidad de Neonatología desde el 10 de junio 2024 que hayan ingresado sin síntomas de gastroenteritis ni diagnóstico asociado a infección por *Rotavirus* y/o *Adenovirus*, que resulten positivos para estos microorganismos mediante cultivo, hisopado rectal o cualquier otro método de detección, y que presenten sintomatología gastrointestinal (1 o más episodios con deposición líquida y/o disgregada)
- **Definición de expuestos:** Todos los pacientes hospitalizados en la Unidad de Neonatología que hayan ingresado sin síntomas de gastroenteritis ni diagnóstico asociado a infección por *Rotavirus* y/o *Adenovirus*, posterior a 24 horas hospitalizados en dicha Unidad desde el 10 de junio 2024.

La curva epidémica se presenta en el siguiente gráfico:

Figura N° 1: Curva epidémica según semana epidemiológica.



Intervenciones realizadas

Ante la detección de este brote, el Programa de Control de Infecciones dictamina lo siguiente:

- Se determina la sectorización de pacientes en la unidad de Neonatología, y el bloqueo de ingreso de nuevos pacientes en 2do piso, salvo casos específicos que cumplan criterio establecido por la unidad de Neonatología.
- La unidad de Neonatología sectorizará pacientes, efectuando movimientos internos con tal de disponer a pacientes positivos para los mismos microorganismos en camas contiguas.
 - Se ubicarán a pacientes positivos para RTV junto a pacientes RTV, y a pacientes RTV y ADV positivos junto a pacientes RTV y ADV positivos.
 - Sala de transición 2do piso, y sala 468 en 4to piso quedarán como “área limpia” para pacientes sin infección gastrointestinal diagnosticada
- Todos los pacientes de la unidad se manejarán con **PAE de contacto**, independiente si poseen resultados positivos para RTV o ADV hasta término de brote epidémico o hasta
- Se considerará como periodo activo de enfermedad lo siguiente:
 - **Paciente RTV(+)**: 5 días desde inicio de síntomas gastrointestinales o fecha de toma de muestra en casos asintomáticos.
 - **Paciente RTV(+) y ADV(+)**: 10 días desde inicio de síntomas gastrointestinales o fecha de toma de muestra en casos asintomáticos.
 - **Paciente sin infección gastrointestinal**: se manejará con PAE de contacto hasta alta hospitalaria, como medida protectora.
- El personal de salud que realiza atención clínica a pacientes positivos debe ser exclusivo.
- Debido a la exposición que presentarán los pacientes hospitalizados en la unidad, se realizarán 2 screening con toma de muestra de RTV y ADV adicionales al ya realizado el día 18/06/24 acorde a periodos de incubación:
 - **1er screening**: 18/06/2024 (ya realizado)
 - **2do screening**: 21/06/2024 (tomar muestra a pacientes que se mantengan hospitalizados en la unidad y que se encuentren negativos en primer screening)
 - **3er screening**: 28/06/2024 (tomar muestra a pacientes que se mantengan hospitalizados en la unidad y que se encuentren negativos a ADV en 1er y 2do screening)

Además, se refuerzan medidas ya instauradas en correos anteriores referentes a **precauciones estándar:**

- Retirar alcohol gel en la totalidad de la unidad.
- Lavado de manos clínico en los momentos correspondientes (antes y después del contacto con el paciente, ante realización de técnica aséptica, y ante contacto con fluidos corporales de riesgo, al contacto con el entorno del paciente, al retiro de guantes)
- El personal clínico a cargo debe registrar tipo, frecuencia, características de deposiciones de los pacientes en ficha clínica.
- Se deberá disponer de basurero asimilable a residuos domiciliarios específico para depositar pañales contaminados. Este basurero deberá contar con tapa, pedal y deberá encontrarse rotulado para su correcta identificación por parte del personal clínico, padres y personal de aseo de SC.
- La ropa de cama del paciente debe salir del aislamiento en bolsa plástica transparente, rotulada con la cantidad en su interior, más la diferenciación con etiqueta "PAE" escrita en rótulo.
- Termómetros, mangos de presión, patos, chatas, etc., de uso individual.
- Uso de EPP PAE contacto: delantal de manga larga desechable, para la atención directa del paciente, guantes de procedimientos de un uso.
- Orden de retiro de EPP: sin retirar los guantes, el delantal se retira envolviendo la cara externa y enrollándose hasta colocarlo dentro del guante para eliminarlo. Posteriormente se realiza lavado de mano. Este procedimiento evita contaminar el ambiente y la ropa.

Visita de padres

- La totalidad de las visitas deberá realizar uso de elementos de protección personal (pechera-guantes- mascarilla quirúrgica).
- La unidad deberá determinar horario específico para la visita, con tal de generar supervisión dirigida por parte del personal clínico, a todos los familiares que ingresen a la unidad, educando sobre lavado de manos y uso de EPP, así como también, supervisión del correcto uso de los elementos.

RAD

- Se suspende toda actividad docente asistencial de pregrado mientras el brote se encuentre vigente.

Aseo hospitalario

- Se deberá realizar aseo hospitalario por parte del personal de la sociedad concesionaria de manera cada 8 horas con solución clorada al 0.1% de manera obligatoria, con el uso de EPP correspondiente a PAE por contacto.
- El personal auxiliar de aseo de SC no deberá realizar rotación ni prestar funciones en otra unidad que no sea Neonatología. Para ello, determinar un personal de aseo para 2do piso, y otro para 4to piso (NEO básica).
- La realización de aseo por ambos personales debe incorporar sala de estar (donde existe microondas- mesa y sillón)
- La SC deberá disponer y realizar supervisión del personal de aseo de Neonatología al menos 3 veces al día.
- El personal auxiliar de la unidad deberá realizar aseo cada 8 horas de superficies comunes: manillas de puertas, mesones de áreas clínicas y áreas administrativas de la unidad, mesas de unidad de pacientes, área de lactario, entre otros, siguiendo con el principio de realizar éste “de limpio a contaminado”. En todos los casos previamente mencionados deberán poseer hoja de registro con hora fecha y firma de responsable.

SEDILE

- Todas las fórmulas que ingresen a la unidad, deberán ser entregadas a personal clínico quien será el encargado de manipular y distribuir este insumo.
- Todas las mamaderas que Neonatología genere, deberán ser segregadas y rotuladas para envío a SEDILE.

Tras el envío de estas indicaciones, el Programa Control de Infecciones realiza capacitaciones en prevención de IAAS al personal de aseo de Sociedad Concesionaria al evidenciar fallas en el manejo y cumplimiento de protocolos de aseo institucional (anexo 2), así también se indica a jefatura de Neonatología, realizar capacitaciones a la totalidad de su personal, medida efectivamente cumplida (anexo 3).

Adicionalmente PCI consulta con Microbiología respecto a procesamiento y manipulación de muestra para RTV y ADV como hipótesis previamente ya mencionada en este informe, evaluando un posible procesamiento incorrecto de la muestra, ante lo cual, Encargado de microbiología asegura que los testeos se encuentran actualizados y con pruebas al día en cuanto a la maquinaria, más expertiz de personal que maneja la muestra. Así también, se consulta con Tecnovigilancia si existe alguna alerta asociada al lote de insumo para procesamiento de muestra, no existiendo ésta según fue informado por referente (anexo 4)

Además, se solicita a Microbiología el reporte del envío de muestras a ISP, sin embargo, el encargado de la unidad informa que las muestras del 18/06 fueron eliminadas por lo que es

imposible realizar envío a ISP de éstas. Por ello, PCI indica que las muestras que se tomen en el nuevo screening (que tiene como objetivo la búsqueda de casos de ADV) sean enviadas a ISP (anexo 5).

Adicionalmente se realizaron visitas en la unidad de Neonatología, tanto en el 2do piso (UPC) como en el 4to piso (básico), en las cuales PCI realizó retroalimentación directa al personal, indicando mejoras en la distribución de los espacios, definiendo de manera categórica áreas sucias y áreas limpias en las unidades, así como área y mesa específica para la entrega de insumos desde SEDILE.

Fechas de Hitos de Brote Epidémico

- **Detección de brote:** 19 de junio 2024
- **Caso índice:** 18 de junio 2024
- **Caso primario:** 1 de junio 2024
- **Inicio de brote (exposición):** 10 de junio 2024
- **Registro en SICARS:** 21 de junio 2024
- **Notificación y toma de conocimiento por SDGA:** 19 de junio 2024
- **Notificación a SSMC:** 19 de junio 2024
- **Autorización en SICARS por SDGA:** 21 de junio 2024
- **Registro de cierre de brote en SICARS:** 07 de julio 2024.

Nota: El comentario ingresado a SICARS sobre cierre de brote el día 08 de julio debió ser modificado por error en digitación en cuanto al n° de casos asociados, por lo que en plataforma el cierre figura el 06/08/24, no obstante, para efectos de este informe se mantiene como fecha de registro de cierre el día 08/07/24.

Desenlace

El último caso sintomático fue diagnosticado el 18 de junio. Este paciente se mantuvo en aislamiento hasta el día 27 de junio, considerando 10 días como periodo de aislamiento. A partir de dicho día se contabilizaron 10 días más como periodo de incubación para ambos agentes (*Rotavirus*, que comprende hasta 72 hrs, y *Adenovirus*, que comprende hasta 10 días). Durante este periodo no se presentaron nuevos casos sintomáticos, por lo que se da cierre al brote el día 07 de julio 2024.

Envío de muestras a ISP

De las muestras tomadas, se envían 7 a ISP para estudio de brote el día 28 de junio 2024, con resultado obtenido el 01 de julio 2024 (anexo 6). Dado los resultados enviados de parte del ISP (todos negativos), se analizaron factores y se tomaron medidas al respecto por parte de Laboratorio HEC relacionadas al test inmunocromatográfico utilizado en esta unidad:

1. Se hicieron testeos de muestras en paralelo con 2 técnicas distintas, teniendo cierta concordancia entre resultados emitidos por ambas técnicas.
2. Se contacta a HUAP y se envían muestras para ser procesadas, obteniendo los mismos resultados tanto en HEC como en HUAP (muestras positivas para RTV), siendo la metodología local en HEC el test inmunocromatográfico, y en HUAP, FilmArray™.
3. Se constató el uso adecuado de los elementos de protección personal para realizar la técnica correspondiente, y esto fue cumplido tal como se indica en manual.
4. Laboratorio contactó a la empresa proveedora del insumo (test), para que esta entregara a HEC otro lote del reactivo en cuestión, con tal de asegurar la calidad de los procesos.
5. Se consultó al proveedor sobre la correcta manipulación y toma de muestra de la deposición para el análisis en test rápido
6. Se realizó reunión entre Laboratorio y PCI local para analizar situación, quedando como factor a trabajar, el proceso de toma de muestra en piso, sin embargo, no hubo mayor afectación en los resultados de las muestras, considerando el testeo paralelo mencionado en el punto n°1.

Letalidad

Respecto a pacientes fallecidos, no se presentan en este brote.

Tabla Cálculo de letalidad asociada a brote por *Rotavirus* y *Adenovirus* en Servicio de Neonatología.

Total Fallecidos	0
Total muertes auditadas	0
Total Casos	5
Muerte asociada (A+B*)	0
Letalidad Asociada	0%
Número de Expuestos	53

**La infección intrahospitalaria contribuyó a la muerte sin ser causa de ella.*

III. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

En total hubo 5 pacientes sintomáticos, de los 19 casos positivos en total. Desde que fue detectado el brote a su cierre transcurrieron **18 días**, con **27 días** de exposición en total.

No se observan fallecimientos asociados al brote y tampoco funcionarios positivos, solo pacientes. Dentro de los casos positivos asintomáticos detectados, hubo mayoritariamente pacientes que se encontraban en la UPC Neonatal (segundo piso) pero también hubo un caso que se detectó en Neonatología Básico (cuarto piso).

Se realizaron visitas y supervisión por parte del equipo de PCI a ambas unidades, pesquizando brechas como por ejemplo en cuanto a la segregación de áreas (limpia y sucia), lo cual queda pendiente realizar las mejoras en conjunto con la Unidad de Operaciones. Se intervino en cuanto la disposición de mamaderas limpias y sucias, con la finalidad de disminuir ingreso de personal no clínico a las salas de Neonatología Básico y de disminuir las instancias en donde puede haber una posible contaminación cruzada.

En cuanto a la coordinación con los equipos de salud, el trabajo mancomunado cobra vital relevancia para poder efectuar una contención efectiva de brotes epidémicos. Tanto la jefatura médica como de matronería, personal de aseo de SC, personal de Operaciones, SEDILE, OIRS, cumplen funciones extremadamente relevantes que abarcan desde un aseo efectivo, a visitas de familiares organizadas y supervisadas, a la correcta distribución de los espacios, a la definición de área limpia y área sucia, y a la supervisión del lavado de manos.

Así también, la mantención de los procesos y reportes ya establecidos por el PCI, como el reporte diario de precauciones adicionales enviado desde las unidades clínicas, la revisión de casos positivos de los distintos agentes etiológicos, entre otros, permite mantener control y conocimiento de los distintos microorganismos presentes en nuestra institución, entre ellos *Rotavirus* y *Adenovirus*, ayudando a prevenir transmisiones y posibles nuevos brotes.

En cuanto al reporte por parte de ISP, laboratorio generó consultas y gestiones para cerciorarse de correcto manejo de la muestra a nivel local. De igual manera, se sugiere realizar refuerzo de metodología de toma de muestra de deposiciones para RTV+ADV, con tal de asegurar que éstas posean la calidad requerida para su análisis.

Anexo 1: Correo con medidas preventivas ante aumento de casos

laas Hec

De: laas Hec
Enviado el: martes, 18 de junio de 2024 16:38
Para: Nicole Cárdenas Meneses; Susana Peña Espinoza; Epidemiología HEC
CC: Paola Fernandez Acevedo; Yadira Perez Paraqueim o; Macarena Escobar Armijo; laas Hec; RAD Hec; María Jose Anaya Zumaeta; Veronica Silva Blanch
Asunto: RE: REPORTE DE PAE DE UNIDADES CLÍNICAS
Datos adjuntos: Res N° 0462, Aprueba Manual de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, HEC 2019 (1).pdf; 2. RESOL. 1721 - Protocolo Aseo Hospitalario (versión 2).pdf

Estimados:

Muy buenas tardes, se informa que nos encontramos con estudio de Brote epidémico por Rotavirus en UPC Neonatología

Se presentan 4 casos entre el 10-06-2024 al 18-06-2024.

- Uno de los casos Thiane Vega, presenta examen positivo tanto para rotavirus y adenovirus del 11-06-2024, por lo que se descarta su nexo entre los casos detectados
- Paciente Djeny-Va Avenard, presenta examen positivo para rotavirus el 13-06-2024 con quiebre clínico, asociándose a nuevo caso de rotavirus, paciente no presenta nexo epidemiológico, al momento de presentar sintomatología paciente no se encontraba en UPC neo, posterior se traslada a cupo actual 238-J.
- Aynara Urrea presenta examen positivo para rotavirus el 10-06-2024, no presenta nexo con Djeny-Va
- Hoy se presenta nuevo caso Ian Sepulveda, paciente de 4 meses que presenta hoy 18-06-2024 deposiciones líquidas, por lo que se realiza examen siendo positivo para rotavirus, siendo posible presentar nexo con alguno de los pacientes con rotavirus ya detectado Aynara o Djeny-Va

Dado a este aumento de casos, se tomaron las siguientes medidas desde el 12 de junio:

- ✦ Retiro de alcohol gel en la totalidad de la unidad
- ✦ Lavado de manos clínico.
- ✦ Sectorización de casos positivos.
- ✦ Propender a mantener personal exclusivo para la atención de estos pacientes
- ✦ Uso de elementos de protección personal (pachera-guantes- mascarilla quirúrgica) ante la atención directa de la totalidad de la unidad (hasta 72 horas posterior a último episodio de deposiciones líquidas en casos asociados)
- ✦ Uso de elementos de protección personal (pachera-guantes- mascarilla quirúrgica) de visitas en la totalidad de la unidad (hasta 72 horas posterior a último episodio de deposiciones líquidas en casos asociados)
- ✦ Caracterización de deposiciones en cada caso.
- ✦ Se solicitar realizar CAU con necesidad de aseo terminal en la unidad
- ✦ Se solito aseo recurrente cada 8 horas con solución clorada 0.5%.

Además, durante la vigilancia epidemiología en la unidad, hoy personal clínico refiere quiebre de protocolo de aseo hospitalario por parte de personal de ISS, donde incurre en no uso de EPP correctamente al realizar los aseos en aislamiento de contacto.

Por lo que a las medidas anteriormente descritas se instruye:

- ✦ Disponer de registro de aseo cada 8 horas por parte de ISS.
- ✦ Disponer de registro de aseo cada 8 horas por personal clínico de la Neonatología.
- ✦ Se suspende actividad docente de pregrado a pacientes con detección de rotavirus en Neonatología
- ✦ Supervisar por personal de Matronería, el correcto aseo por parte del personal de ISS y el uso correcto de EPP (según protocolo institucional, se adjunta).
- ✦ Extremar supervisión de lavado de manos tanto a personal clínico, personal concesionado y visitas

De: IaaS Hec

Enviado el: jueves, 13 de junio de 2024 14:13

Para: Nicole Cárdenas Meneses <nicole.cardenas@redsalud.gob.cl>; Susana Peña Espinoza

<susana.pena@redsalud.gob.cl>; Epidemiología HEC <epidemiologia.hec@redsalud.gob.cl>

CC: Paola Fernandez Acevedo <paola.fernandez@redsalud.gob.cl>; Yadira Perez Paraqueimo

<yadira.perez@redsalud.gob.cl>; Macarena Escobar Armijo <macarena.escobar@redsalud.gob.cl>; IaaS Hec

<iaas.hec@redsalud.gob.cl>

Asunto: RE: REPORTE DE PAE DE UNIDADES CLÍNICAS

Estimados

Muy buenas tardes.

Junto con saludar, se envía acta de reunión realizada hoy 13-06-2024.

A raíz de aumento de casos presentados de rotavirus en esta semana, se realiza reunión con equipo Médico y Jefatura de Matronería.

Se evalúan dos casos a los que se realiza examen de rotavirus.

1° caso [REDACTED] de UPC NEO cupo 238. Se realizan 3 exámenes 26-05-2024, el 02-06-2024 y el 10-06-2024 resultando positivo para RTV, con menos de 10 días entre cada examen, sin quiebre clínico. El equipo clínico indica que los exámenes posteriores al 26-05-2024, se realizan ya que paciente requiere examen en el Hospital Roberto del Río y se realiza en forma preventiva suspensión de la posible asignación de la hora. Paciente como no presenta quiebre clínico, se define que no es una nueva infección y lo que se detecta sería relacionado a la misma infección, la que no se encontraría activa.

2° caso [REDACTED], paciente en Neonatología básica cuarto piso cupo 469-d, paciente presenta 4 exámenes donde se detecta RTV, el 17-05-2024, 22-05-2024, 27-05-2024 y el 13-06-2024. Siendo los exámenes del 22-05-2024 y 27-05-2024 [REDACTED] venir suspensión y asignación de hora para un examen en extrasistema. El 13-06-2024 se realiza debido a que paciente, [REDACTED] ostomía, deposición de gran cantidad. Por lo que se realiza nuevo examen siendo positivo para RTV, en este caso paciente presenta periodo de recuperación de más de 3 días y quiebre clínico, con examen del 4 de junio negativo para rota [REDACTED]. Este cuadro sería una nueva infección. Debiendo manejar con PAE contacto, supervisión de lavado de manos y uso correcto de EPP tanto a padres como del personal clínico, manteniendo las medidas enviadas el miércoles 12-06-2024 por correo:

- ✚ Retiro de alcohol gel en la totalidad de la unidad.
- ✚ Lavado de manos clínico.
- ✚ Sectorización de casos positivos.

De: IaaS Hec <iaas.hec@redsalud.gob.cl>

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2024 13:58

Para: Susana Peña Espinoza <susana.penae@redsalud.gob.cl>; Epidemiología HEC

<epidemiologia.hec@redsalud.gob.cl>; Paola Fernández Acevedo <paola.fernandez@redsalud.gob.cl>

CC: beas.hec <beas.hec@redsalud.gob.cl>; Nicole Cárdenas Meneses <nicole.cardenas@redsalud.gob.cl>; Paola Fernández Acevedo <paola.fernandez@redsalud.gob.cl>; Yadira Pérez Paraquélmo <yadira.perez@redsalud.gob.cl>; Macarena Escobar Armijo <macarena.escobar@redsalud.gob.cl>; IaaS Hec <iaas.hec@redsalud.gob.cl>

Asunto: RE: REPORTE DE PAE DE UNIDADES CLÍNICAS

Estimadas:

Junto con saludar, las últimas 24 horas se ha observado un aumento de casos (2) asociado a RTV en pacientes con hospitalización mayor a 48 horas desde su ingreso.

En vuestra unidad hasta el día 11 de junio permanece menor M.M cupo transición quien RTV (+) 11-06 y persistencia de deposiciones líquidas, permanece aislado desde su primer episodio. Se realiza evaluación de nuevos casos, los cuales no tienen nexos epidemiológicos de acuerdo a análisis en conjunto a supervisora de la unidad con primer caso (M.M.), sin embargo, últimos nuevos casos sí presentan nexo epidemiológico entre sí.

Dicho lo anterior es por lo que nos mantenemos alerta ante posible brote epidemiológico y se instauran las siguientes medidas preventivas:

- ✦ Retiro de alcohol gel en la totalidad de la unidad.
- ✦ Lavado de manos clínico.
- ✦ Sectorización de casos positivos.
- ✦ Propender a mantener personal exclusivo para la atención de estos pacientes.
- ✦ Uso de elementos de protección personal (pechera-guantes- mascarilla quirúrgica) ante la atención directa de la totalidad de la unidad (hasta 72 horas posterior a último episodio de deposiciones líquidas en casos asociados)
- ✦ Uso de elementos de protección personal (pechera-guantes- mascarilla quirúrgica) de visitas en la totalidad de la unidad (hasta 72 horas posterior a último episodio de deposiciones líquidas en casos asociados)
- ✦ Caracterización de deposiciones en cada caso.
- ✦ Se solicitará realizar CAU con necesidad de aseo terminal en la unidad (copio a EU Paola Fernández)
- ✦ Se solita aseo recurrente cada 8 horas con solución clorada 0.1%.
- ✦ Mañana se realizará visita AM con médica encargada de PCI, para evaluación de caso primario M.M.

Quedamos atentas a sus comentarios y con total disponibilidad de cooperar en lo que necesiten saludos cordiales

Anexo 2: Capacitación de personal de Neonatología (21 y 24 de junio)

ASISTENCIA CAPACITACIÓN

CARIBE 20170

FECHA DE
MAYO 16 JUNIO 1998 Participación Caribea.

SIGUE EN
CONTRA DE

CR 20

9.00

VERIFICAR Y REVISAR

[illegible]

HOSPITAL **H. GARMEN** **ASISTENCIA CAPACITACIÓN** **Y JORNADA**
PREVENCIÓN **INVESTIGACIÓN** **INFORMACIÓN** **DE**
PREVENCIÓN **INVESTIGACIÓN** **INFORMACIÓN** **DE**

TEMAS: curso de manejo de Terapias conductuales

FECHA: 25/04/24

RELATOR: Alfonso Garmen

OTRA INICIA: 22:00 - 03:00

OTRA INICIA:

	NUMBER	KEY	CARGO	STOPS
1	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
2	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
3	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
4	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
5	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
6	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
7	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
8	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
9	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
10	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
11	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
12	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
13	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
14	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
15	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
16	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
17	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
18	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
19	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6
20	Cheney, Ted Sam	10-19-82-6	10-19-82-6	10-19-82-6

HOSPITAL
DR. JOSE CARREON
CALLE 25 DE NOVIEMBRE 1000
TELEFONO 22222222

ASISTENCIA REUNIÓN

Nombre del Paciente y EPP: Guillermo Esteban

FECHA: 21/06/24

RELATOR: Guillermo Esteban

USUARIO: Guillermo Esteban

USUARIO: Guillermo Esteban

	NOMBER	SOURCE ELECTRONICS	CARGO	THIRDA
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

ASISTENCIA REUNIÓN

Formulario de Asistencia

Fecha: 21-05-2024 *16 de mayo de 2024*

Evento: Sesión de Trabajo y Vigencia de la CAS

Nombre y Apellido: _____

Identificación: _____

Asistencia: ☐ Asistió ☐ No Asistió

Observaciones: _____

[illegible]

Anexo 3: Capacitación de personal de aseo de SC (24 de junio)

HOSPITAL EL CARMEN Dr. Luis Valentín Ferrada	ACTA DE REUNION DEPARTAMENTO CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
REUNION	Capacitación
FECHA	24 JUNIO 2024
LUGAR	IAAS
TEMA	Aseo Hospitalario

NOMBRE	SERVICIO/UNIDAD	ANEXO	FIRMA
Dora Escamilla	SC Prácticos	22428	[Firma]
Agustín Cuatrecasas R.	S.C.		[Firma]
Karen Saiz P.	SC		[Firma]
Karen Turi P.	SC		[Firma]
Marta Vique	Supervisoras ISS		[Firma]
Kelise Kantel	Auxiliar ISS		[Firma]
Chantal Benítez	Auxiliar ISS		[Firma]
Pablo Villalobos	S.C.		[Firma]
Carolina Ríos	S.C.		[Firma]
Nathaly Chiquito M.	S.C.		[Firma]
Pamela Miranda	Supervisoras ISS		[Firma]
Mirka Riquelme	Supervisoras ISS		[Firma]
Delia Ríos	Operario		[Firma]
Carolina Ríos	Operario		[Firma]

HOSPITAL EL CARMEN Dr. Luis Valentín Ferrada	ACTA DE REUNION DEPARTAMENTO CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
REUNION	Capacitación
FECHA	24 JUNIO 2024
LUGAR	IAAS
TEMA	Aseo Hospitalario

NOMBRE	SERVICIO/UNIDAD	ANEXO	FIRMA
Cecilia Burgos	Supervisoras ISS		[Firma]
Wilfredo Muro	Auxiliar		[Firma]
Sandra Velasco	Supervisoras ISS		[Firma]
Wilsa Monte	Auxiliar		[Firma]
Martín de Cón	Aux de Aseo		[Firma]
Dora Villalobos	Aux de Aseo		[Firma]
Bilva Ríos	Sección Aseo		[Firma]
Yoselin Jarama	ATA Bodega		[Firma]
Marta Ríos	Aux de Neo		[Firma]
/			

Anexo 4: Consulta a Tecnovigilancia.

laas Hec

De: laas Hec
Enviado el: martes, 25 de junio de 2024 13:47
Para: Bastian Leyton Vergara; Calidad Hec
CC: Macarena Escobar Armijo; Camilo Ricardo Alcamán Rodríguez; Clara Gálvez Leal; Myriam Pizarro
Asunto: RE: Consulta tecnovigilancia en contexto de brote epidémico en Neonatología

Muchas gracias!
Atte.,



**Programa Control de
Infecciones**

Dpto. de Calidad y Seguridad del Paciente
Fono: (56-2) 26120094 / Anexo MINSAL: 220094
Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
Camino Rinconada 1201, Maipú.



De: Bastian Leyton Vergara <bastian.leyton@redsalud.gob.cl>
Enviado el: martes, 25 de junio de 2024 13:46
Para: laas Hec <laas.hec@redsalud.gob.cl>; Calidad Hec <calidad.hec@redsalud.gob.cl>
CC: Macarena Escobar Armijo <macarena.escobar@redsalud.gob.cl>; Camilo Ricardo Alcamán Rodríguez <camilo.alcaman@redsalud.gob.cl>; Clara Gálvez Leal <clara.galvez@redsalud.gob.cl>; Myriam Pizarro <myriam.pizarro@redsalud.gob.cl>
Asunto: RE: Consulta tecnovigilancia en contexto de brote epidémico en Neonatología

Estimadas,
Junto con saludar, comentar que no existen alertas asociadas al DM descrito en correo de arrastre.
Saludos cordiales.



Bastian Leyton Vergara
Especialista en Tecnovigilancia
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente
Fono: (56-9) 48026781 / Anexo MINSAL: 220550
Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
Camino Rinconada 1201, Maipú.



De: laas Hec <laas.hec@redsalud.gob.ci>

Enviado el: martes, 25 de junio de 2024 13:28

Para: Bastian Leyton Vergara <bastian.leyton@redsalud.gob.ci>; Calidad Hec <calidad.hec@redsalud.gob.ci>

CC: Macarena Escobar Armijo <macarena.escobar@redsalud.gob.ci>; laas Hec <laas.hec@redsalud.gob.ci>; Camilo

Ricardo Alcamán Rodríguez <camilo.alcaman@redsalud.gob.ci>; Clara Gálvez Leal <clara.galvez@redsalud.gob.ci>;

Myriam Pizarro <myriam.pizarro@redsalud.gob.ci>

Asunto: Consulta tecnovigilancia en contexto de brote epidémico en Neonatología

Estimados,

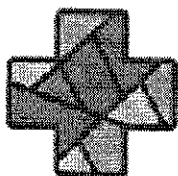
Junto con saludar, enviamos correo para consultar si existe alguna alerta asociada al insumo utilizado para el procesamiento en laboratorio para detectar *Rotavirus* y *Adenovirus* en muestras de deposiciones en nuestra institución.

El insumo utilizado de kit de detección se llama **OnSite Rota/Adeno Ag Rapid Test**, lote F0821U4A00D, con fecha de elaboración 22-03-2023 y fecha de vencimiento del 21-08-2025, de CTK Biotek.

Quedamos atentas a respuesta.

Saludos cordiales.

Atte.,



**HOSPITAL
EL CARMEN**
Dr. Luis Valentín Ferrada

Programa Control de Infecciones

Dpto. de Calidad y Seguridad del Paciente

Fono: (55-2) 26120094 / Anexo MINSA: 220094

Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada

Camino Rinconada 1201, Maipú.



Anexo 5: Capacitación de personal de aseo de SC (25 de junio)

laas Hec

De: IaaS Hec
Enviado el: martes, 25 de junio de 2024 13:08
Para: Camilo Ricardo Alcamán Rodríguez
CC: Myriam Pizarro; Clara Gálvez Leal; Macarena Escobar Armijo; Veronica Silva Blanchy; Nicole Cárdenas Meneses; Susana Peña Espinoza; IaaS Hec
Asunto: RE: Solicitud información y verificables de testeos. (cód. nacional de brote)
Datos adjuntos: Documentación

Estimado Camilo,

Junto con saludar, te comento que el brote epidémico por RTVY RTV/ADV ya cuenta con código nacional para enviar muestras a ISP el cual es: **4012**.

Las muestras que deben ser enviadas a ISP serán aquellas muestras pertenecientes a los siguientes pacientes, siempre y cuando éstos se encuentren hospitalizados aún el día 28 de junio:

RUN/N° historia	Paciente
[REDACTED]-3	[REDACTED]
[REDACTED]-8	[REDACTED] A
[REDACTED]-5	[REDACTED]
[REDACTED]-7	[REDACTED] D
[REDACTED]	NN NN NN
[REDACTED]-7	[REDACTED]
[REDACTED]-0	[REDACTED] D
[REDACTED] K	[REDACTED]
[REDACTED] K	[REDACTED] A
[REDACTED]-9	[REDACTED]
[REDACTED]-6	[REDACTED] E
[REDACTED]-6	[REDACTED]
[REDACTED]-2	[REDACTED]

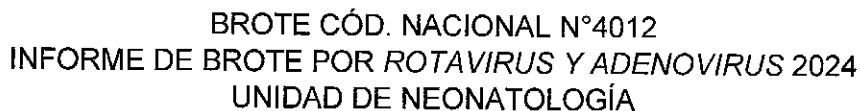
- En verde se encuentran los pacientes que ya resultaron positivos de los que deben enviar nueva muestra.
- En cursiva los pacientes que han sido positivos sólo para RTV.
- Resto de pacientes resultaron negativos en testeo del 21 de junio y corresponde volver a testear en búsqueda de ADV.

Ya que enviamos este correo en arrastre de la solicitud anterior realizada, adjunto vuestra respuesta para conocimiento del equipo de Neonatología, a quienes copio para llevar a cabo la instrucción de testear a los pacientes mencionados en cuadro anterior.

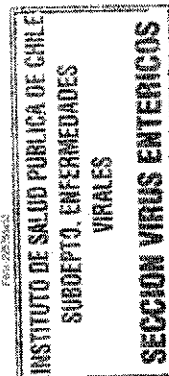
Quedamos atentas a respuesta, muchas gracias.

Atte.,

Anexo 6: Informe ISP (Página siguiente)

[illegible][illegible][illegible]

上海外灘四號



THE
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

WASHINGTON, D. C.